



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**TERM OF REFERENCE (TOR)
DRILL EMERGENCY MATERNAL NEONATAL
TAHUN 2024**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

TERM OF REFERENCE (TOR)
DRILL EMERGENCY MATERNAL NEONATAL
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari hasil monitoring evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pada tanggal 24 April 2024 untuk Rumah Sakit diharapkan melakukan Drill Emergency penatalaksanaan kegawatdaruratan Maternal Neonatal secara berkala, agar saat ada kejadian kegawatdaruratan pasien maternal dan neonatal bisa menangani dengan cepat, tepat dan akurat sehingga pasien tertangani dengan baik.

Rumah sakit PONEK 24 jam merupakan bagian dari sistem rujukan dalam pelayanan kegawatdaruratan dalam maternal dan neonatal, yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Kunci keberhasilan PONEK adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi, prasarana, sarana dan kompetensi yang handal.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, Pemerintah menetapkan beberapa program nasional yang menjadi prioritas. Program prioritas tersebut yaitu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan angka kesehatan ibu dan bayi.

Untuk mencapai kompetensi dalam bidang tertentu, tenaga kesehatan memerlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku dalam pelayanan kepada pasien.

Salah satu program dari program PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) sehubungan dengan pemberian pelayanan kesehatan adalah Pendidikan dan Pelatihan PONEK di Pelayanan Kesehatan. Untuk itu Rumah Sakit, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan sudah saatnya melaksanakan program PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif). Untuk mencapai program ini dengan baik dan benar perlu mengadakan pelatihan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) tentang kegawatdaruratan obstetric dan neonatal terkait Pelayanan Kesehatan kepada seluruh staf rumah sakit.

HEMORAGIK POST PARTUM (HPP)

HPP adalah : keluarnya darah dari jalan lahir segera setelah melahirkan. Memperkirakan jumlah perdarahan. Perdarahan setelah melahirkan dengan jumlah wajar merupakan hal normal terjadi wajar merupakan hal yang normal terjadi dan hal ini disebut lochea atau nifas. Namun kondisi ini bisa menjadi kondisi yang perlu dikhawatirkan Ketika darah yang keluar sangat banyak melebihi 500 c dalam 24 jam setelah melahirkan.

Memperkiraan jumlah perdarahan

1. Belum ada metode yang akurat
2. Meletakkan penampung darah di bawah bokong ibu, selain tidak nyaman juga tidak menjamin pengukuran yang tepat
3. Pengukuran dengan gelas ukur dapat terganggu dengan tambahan cairan lain atau jumlah yang hilang akibat material penyerap (kain, kasa, pakaian, dsb)

Estimasi Simtomatik

1. Bila perdarahan menyebabkan terjadinya perubahan tanda vital (hipotensi) maka jumlah darah yang keluar telah mencapai 1000-1200 ml.
2. Bila terjadi syok hipovolemik maka jumlah perdarahan telah mencapai 2000-2500 ml.

Tabel 1.1 Penilaian klinik

Penilaian Klinik		
Gejala & Tanda	Penyulit	Diagnosis Kerja
Darah Segar Setelah Bayi Lahir Kontraksi Uterus Baik Plasenta Lengkap	Pucat Lemah Menggigil	Laserasi Jalan Lahir
Kontraksi Uterus (-) / Lembek Perdarahan Segera Setelah Anak Lahir	Syok Bekuan Darah Di Serviks	Atonia
Plasenta Belum Lahir ≥ 30 Menit Perdarahan Segera	Tali Pusat Putus (Inversio Uteri) Perdarahan Lanjut	Retensio dan Separasi Parsial

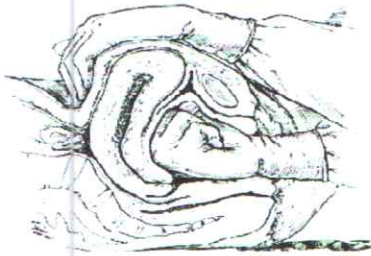
Penanganan Umum

1. Selalu siapkan tindakan gawat darurat
2. Manajemen aktif kala III
3. Minta pertolongan pada petugas lain utk membantu bila dimungkinkan
4. Bila syok , lakukan segera penanganan
5. Periksa kandung kemih -> kosongkan
6. Cari penyebab perdarahan
7. Sambil melakukan tindakan secara cepat
8. Atasi syok
9. Berikan Oksitosin 10 iu im, dilanjutkan 20 iu/ 500 ml RL/ nacl 0,9%
10. Pastikan plasenta lahir lengkap
11. Perdarahan berlanjut:
12. Pantau keseimbangan cairan
13. Sambil mencari penyebab perdarahan

Atonia uteri

1. Mengenal ibu dgn kondisi berisiko
2. Tegakkan diagnosis kerja
3. Pasang infus berikan uterotonika
4. Pastikan plasenta lahir lengkap
5. Bila perlu tranfusi darah
6. Lakukan tindakan spesifik
 - a. Kompresi bimanual eksternal
 - b. Kompresi bimanual internal
 - c. Kompresi aorta abdominalis
 - d. Tampon kondom kateter

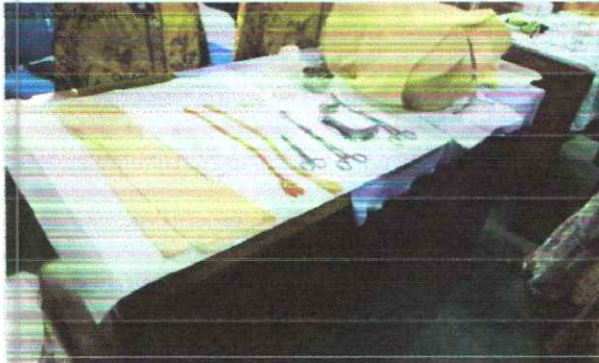
Kompresi Bimanual Internal



Pemasangan Kondom kateter Persiapan Alat



Persiapan Alat



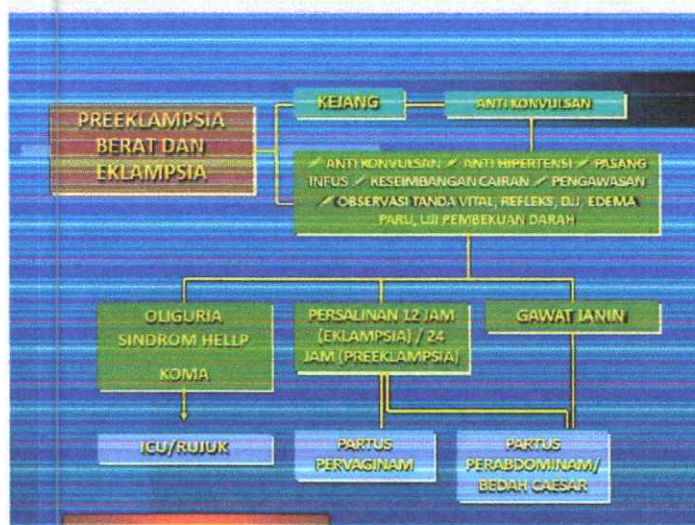
Pemasangan Kondom kateter



PRE EKLAMSI DAN EKLAMSI

Pre Eklamsi Dan Eklamsia adalah komplikasi kehamilan darah tinggi yang bisa mengancam jiwa. Pre eklamsi adalah salah satu komplikasi kehamilan yang terjadi karena tekanan darah terlalu tinggi semasa mengandung bayi. Sedangkan eklamsia adalah komplikasi lanjut dari pre eklamsia berupa gejala kejang, sakit kepala, penurunan produksi air seni dan beberapa kondisi medis.

Alur terapi



Resusitasi neonatus adalah usaha yang dilakukan pada neonatus dengan gangguan transisi kehidupan, yang awalnya tergantung pada plasenta ibu menjadi proses pernapasan secara independen. Tindakan resusitasi neonatus bertujuan untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan menurunkan mortalitas neonatus. Resusitasi neonatus diindikasikan pada bayi baru lahir yang mengalami gangguan pernapasan pada saat kelahiran. Gangguan pernapasan pada neonatus sering terjadi pada persalinan preterm, presentasi bokong, kehamilan multipel, sepsis pada ibu, dan gangguan antepartum lainnya.

Setiap tahunnya 10 juta bayi yang baru lahir tidak dapat bernapas spontan sehingga membutuhkan bantuan resusitasi untuk bertahan hidup, terutama pada 1 menit pertama yang merupakan *golden minute*. Hal ini juga ditunjang dengan data yang menunjukkan

bahwa 10% bayi baru lahir memerlukan resusitasi agar dapat bernapas. Tindakan resusitasi bertujuan untuk meningkatkan *survival* neonatus. Berdasarkan data penelitian, tindakan resusitasi neonatus yang dilakukan secara benar dapat menurunkan mortalitas bayi pada saat lahir, usia 1 hari, dan 7 hari.

Teknik resusitasi yang baik memerlukan peralatan yang baik dan tim yang memiliki kemampuan yang baik dan berpengalaman. Selain itu, komunikasi dan pelatihan terkait resusitasi juga penting dilakukan untuk melakukan resusitasi neonatus yang berkualitas.

Indikasi resusitasi neonatus adalah neonatus yang mengalami gangguan pada saat kelahiran, terutama gangguan pernapasan (asfiksia neonatus). Gangguan pernapasan ditandai dengan adanya perubahan pola napas menjadi lebih pelan dan berkurang secara frekuensi, kemudian dapat berhenti sehingga berlanjut sebagai apneu. Resusitasi neonatus lebih sering dilakukan pada persalinan preterm kurang dari 35 minggu, presentasi bokong, kehamilan multipel, dan sepsis maternal. Selain itu, juga dilakukan pada neonatus dengan kondisi syok, pasca operasi, dan kondisi menurun akibat patologi tertentu.

Beberapa penyebab gangguan pernapasan pada neonatus, antara lain:

1. Gangguan kongenital yang dapat menyebabkan masalah respirasi, seperti hernia diafragmatika, atau hipoplasia pulmonar.
2. Lesi paru kistik
3. Aspirasi meconium

Penilaian kondisi neonatus biasa dilakukan dengan menggunakan skor Apgar. Selain usaha napas, komponen lain yang dinilai adalah warna kulit, nadi, respons terhadap stimulasi, dan tonus. Masing-masing memiliki rentang nilai 0-2 yang dinilai pada menit pertama dan kelima. Skor ini bertujuan untuk memprediksi keluaran (*outcome*) jangka pendek dan panjang pada neonatus.

Prinsip dasar teknik resusitasi neonatus adalah penilaian awal, stabilisasi awal, ventilasi dan oksigenasi, kompresi dada, serta pemberian epinefrin dan volume cairan.

1.2 Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Kesehatan No.1051 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)24 jam di Rumah Sakit
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

1.3 Maksud dan Tujuan Pelatihan

1. Maksud

Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh tenaga medis di rumah sakit agar mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif

2. Tujuan Umum

Meningkatkan pelayanan Maternal dan Neonatal yang bermutu dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia.

3. Tujuan Khusus

- a. Terlaksananya manajemen pelayanan maternal dan perinatal dari aspek administrasi & Manajemen, kompetensi SDM, fasilitas dan sarana serta prosedur pelayanan Rumah Sakit.
- b. Pembinaan dan pengawasan pelayanan maternal dan perinatal di Rumah Sakit.
- c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM dalam menghadapi dan menangani kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Susunan Panitia

NAMA	TIM	TUGAS
Siti Zaimah Amd. Keb	Ketua Panitia	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara. Hasil akhir : LPJ
Triasih Amd.Keb	Sekretaris Acara (Notulen)	bertanggung jawab terhadap pendokumentasian seluruh dokumen dan notulen. Hasil akhir : 1) notulen 2) LPJ
Elok Oktaviani Sp.OG	Moderator	bertanggungjawab sebagai moderator dan mengaktifkan tanya jawab peserta. Hasil akhir : ringkasan persesi dan tanya jawab
Aulia Paramita,Amd.keb	PJ Absensi,dan Operator	bertanggungjawab terhadap kelengkapan absensi dan menyiapkan serta membagikan kuesioner pelatihan. Hasil akhir: rekap absensi dan kuesioner pelatihan bertanggungjawab terhadap slide materi dan sound system
Fifi Wahyuni Amd.Keb	Sie Dokumentasi dan sie konsumsi	bertanggungjawab sebagai fotografer. Hasil akhir : foto di LPJ bertanggungjawab terhadap konsumsi pemateri dan peserta
Elisa Lifatinnura Str.Keb	Sie Perlengkapan dan Sie Penunjang	Bertanggungjawab terhadap kelengkapan peralatan, peminjaman, dan pengembalian alat. Mengambilkan

		alat2 yag belum tersedia saat acara bertanggungjawab mengkoordinir peserta untuk patuh dengan jadwal pelatihan
Novi Ratnasari, S.E	Bendahara	Bertanggungjawab terhadap anggaran biaya kegiatan

2.2 Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Drill emergency dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali.

a. Pelaksanaan ke 1:

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 29 Mei 2024
3. Pukul : 14.00 s/d 15.30 WIB
4. Lama Pelatihan : 90 menit
5. Tempat : Hall Sakura Lantai 5 RS Prima Husada Malang

b. Pelaksanaan ke 2 :

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 7 Agustus 2024
3. Pukul : 14.00 s/d 15.30 WIB
4. Lama Pelatihan : 90 menit
5. Tempat : Hall Sakura Lantai 5 RS Prima Husada Malang

c. Pelaksanaan ke 3 :

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 6 Novemberr 2024
3. Pukul : 14.00 s/d 15.30 WIB
4. Lama Pelatihan : 90 menit
5. Tempat : Hall Sakura Lantai 5 RS Prima Husada Malang

d. Pelaksanaan tahun 2025 akan di Jadwalkan Kembali.

2.3 Rencana Rapat Panitia

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 20 Mei 2024
3. Pukul : 14.00 s/d 15.00 WIB
4. Lama Pelatihan : 60 menit
5. Tempat : Ruang Maternitas RS Prima Husada Malang

2.4 Sasaran atau Peserta

Seluruh Tim Ponek RS Prima Husada Malang sejumlah Peserta

NO	PESERTA	JUMLAH
1	Kabid Pelayanan Medis	1
2	Kabid Keperawatan	1
3	PLT. Kabid Penunjang	1
4	Bidan RS	24
5	Perawat Neonatologi	8
Total		35

2.5 Susunan Acara Lengkap

JAM	DURASI	MATERI	EVALUATOR
14.00-14.05	5 menit	Absensi	Panitia
14.05-14.10	5 menit	Safety Breafing	Panitia
14.10-14.40	30 menit	Drill Emergency Maternal	Panitia dan dr. Tari
14.40-15.10	30 menit	Drill Emergency neonatai	Panitia dan dr. Tari
15.10-15.25	15 menit	Sesi Tanya Jawab	Panitia
15.25-15.30	5 menit	Doa & Penutup	Panitia

2.6 Evaluator

dr. Wiryantati Akhdani Pratiwi

2.7 Media

- 1.LCD
- 2.Laptop
- 3.Sound system
- 4.Alat Tulis
- 5.Peralatan dan Obat-obatan Emergency Maternal Neonatal

2.8 Metode

1. Diskusi
2. Demonstrasi
3. Role Play
4. Tanya Jawab

2.9 Kebutuhan Anggaran

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	KEGIATAN	KEBUTUHAN	SATUAN	HARGA	SUMBER DANA
	29 Mei 2024	Drill Emergency	• Fee Evaluator dr.Wiryantati Akhdani Pratiwi	1 orang	Rp. 0,-	-
	7 Agustus 2024					
	6 November 2024		• Konsumsi Evaluator	1 orang x 3	Rp.60.000,-	Dapur RS Prima Husada Malang
			• Snack Evaluator	1 orang x 3	Rp. 30.000,-	Dapur RS Prima Husada Malang
			• Air Mineral 220 ml	2 Dus x 3	Rp. 126.000,-	Dapur RS Prima Husada Malang
TOTAL					Rp.216.000,-	

III. MONITORING & EVALUASI

3.1 Monitoring

Monitoring dilaksanakan saat persiapan pelaksanaan dan pembuatan pelaporan serta aplikasi di lapangan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Evaluasi berupa peserta bisa melakukan penatalaksanaan kegawatdaruratan maternal Neonatal secara cepat tepat dan akurat.

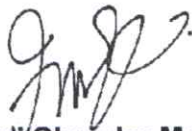
3.2 Evaluasi

Evaluasi berupa peserta bisa melakukan penatalaksanaan kegawatdaruratan maternal Neonatal secara cepat tepat dan akurat.

IV. PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat sebagai acuan dalam pelaksanaan Drill Emergency, di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Suksesnya acara ini memerlukan dukungan dan Kerjasama dari seluruh staf yang ada dan agar tujuan orientasi tercapai sebagaimana yang diharapkan. Atas perhatian dan Kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
SDM RS Prima Husada Malang



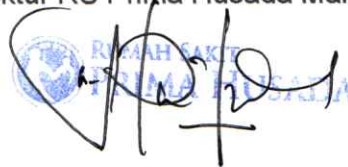
Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi

Malang, 03 Mei 2024
Ketua Panitia



Siti Zaimah, A.Md.Keb

Disetujui Oleh
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN**1. Daftar Nama Undangan Drill Emergency**

NO	UNIT	NAMA
1.	PLT Kepala Bidang pelayanan	dr. Wiryantati Akhdani Pratiwi
2.	PLT Kepala Bidang Penunjang	Putri Indah Purnamasari Amd.Keb
3.	Kepala Bidang Keperawatan	Very Susanto S.Kep.,Ns
4.	Kepala Unit MOD	Daning Pravitia YSM S.Tr.Keb
5.	Kepala Ruang Maternitas	Siti Zaimah Amd.Keb
6.	Kelapa Neonatologi	Dhara Putri Meryda S.Kep.,Ns
7.	Kepala Ruang IRJA	Puput Sekar Nariratih,Amd.Keb
8.	Maternitas	Triasih Amd.Keb
9.	Maternitas	Uswatul Chorida Amd.Keb
10.	Maternitas	Elok Oktaviana Amd.Keb
11.	Maternitas	Aulia Paramita Amd.Keb
12.	Maternitas	Elisa Lifatinnura,Str.Keb
13.	Maternitas	Faiza Muawanah Z.SST
14.	Maternitas	Putri adi Ara Ramadhania Amd.Keb
15.	Maternitas	Fifi wahyuningsih Amd.Keb
16.	Maternitas	Aneta Putri Amd.Keb
17.	Maternitas	Novita Rosunah Amd.Keb
18.	Maternitas	Adhita Krisna Prastiti, S.Tr, Keb
19.	Maternitas	Agustina Kusuma W,S.Tr.Keb
20.	Ponek IGD	Anggarani Dwi Pratiwi,Amd.Keb
21.	Ponek IGD	Wahyuni Amd.Keb
22.	Ponek IGD	Nining Trisari Am.Keb
23.	Penek IGD	Indrikhatul Inaya S.ST.Keb
24.	Ponek IGD	Ria Widyawati Amd.Keb
25.	Neonatologi	Ns.Dyah Dwi Wahyuningsih S.Kep
26.	Neonatologi	Diah Lusiana Eko Tohari Amd.Keb
27.	Neonatologi	Sefira Herisky Amd>keb
28.	Neonatologi	Ns.Rismaya Felantriardianti.S.Kep
29.	Neonatologi	Agustia Feronika Sari Amd.Keb
30.	Neonatologi	Rista Alfia sari Amd.Keb
31.	Neonatologi	Safitri Retno Kurniawati Amd.Kep
32.	IRJA	Tuti Dwi Jayanti Amd.Keb
33.	IRJA	Leny Puji Rahayu Amd.Keb
34.	IRJA	Nurul Azizah Jihad F, S.Tr, Keb
35.	PIPP	Novita Pratama maulida Am.Keb